一页流程 | 眼内注药后非感染性眼内炎症

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2025

1 注药后动态监测

第 1 天 /1 周 /4 周；显著视降或畏光 → 立即就诊；持续 2 d 以上不适 / 飞蚊 → 及时就诊。

2025 刊 p500–501 / PDF9–10

2 是否已排除感染及伪装?

否 / 不确定 → 完成鉴别，不能直接按无菌炎症处理；完成 → 系统查 RV/RO 。

2025 刊 p500 / PDF9

3 影像及分支

照相 +FFA 看灌注； FFA 禁忌可 OCTA ，混浊 B 超。无 RV/RO 、 RV 、 RO 三分支按部位 / 严重度用药。

2025 刊 p500 、 502 / PDF9 、 11

4 阶梯治疗及疗效判断

激素充分治疗不缓解 / 加重 → 重新排感染； RV/RO → 更积极抗炎、定期 FFA 、按需升级。

2025 刊 p501–502 / PDF10–11

5 炎症静止与基础病

活动期避免相同 / 同类再注；普通 SIOI 激光仅静止后广泛无灌注 / 新生血管， HOCRV 另评估。

2025 刊 p502 / PDF11

6 随访至完全静止

所有确诊者缩短复诊间隔，重复查延迟 RV/RO ；黄斑缺血影响预后，统一增频间隔 / 疗程未明确。

2025 刊 p500 、 502–503 / PDF9 、 11–12

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。